讓每一個人都被接住：

推動不利處境族群心理健康融入所有政策

「生活經驗被聽見：真實的聲音，真實的改變。」

- WHO 2026

台灣照顧管理協會 榮譽理事長

張淑慧

等落水才撈救的下游思維

僅佔心理健康影響因子的 **20%**

依賴後端醫療與危機處理，將心理健康視為單一部門的業務科目。



決定心理韌性的社會環境因子

佔心理健康影響因子的 **80%**

心理健康的好壞，取決於居住、收入、教育、照顧負擔與歧視經驗。



「壓力、資源缺乏與求助門檻的疊加，不是多開一間諮商室就能解決的。」

新住民婦女

數據：求助專業協助比例低於 15%

盲點：語言與文化隔閡阻斷求助意願，服務分散於不同行政系統。

缺口：極度缺乏具備心理健康專業訓練的多語通譯，形成跨世代的公衛隱憂。

兒童及青少年

數據：17.7% 青少年面臨中度以上情緒困擾

盲點：資源過度集中於15歲以上與主流校園內，忽略14歲以下、中輟生與受虐兒。

缺口：決策桌上缺乏兒少本人的聲音，違反《兒童權利公約》精神。

身心障礙者

數據：全台逾 120 萬名身障者面臨系統性排斥

盲點：心理支持常被視為「額外福利」而非「基本權利」。

缺口：缺乏明確的精神病床去機構化路徑；實體與資訊無障礙嚴重不足。

高齡長者

數據：自殺率高居各年齡之冠 (27.0/十萬人)

盲點：長者的憂鬱與孤獨常被社會誤認為「正常老化」。

缺口：長照體系高度側重身體功能，評估流程缺心理指標，忽視「社會孤立」的殺傷力。

被諮詢，不等於被當成夥伴。

資料來源：WHO《心理健康地圖集2024》



Nothing about us without us!

「沒有我們的參與，不要替我們做決定！」有生活經驗的人必須是平等的決策夥伴，而不僅是分享悲情故事的工具。

英國

社會處方
(Social Prescribing)

走出診間的醫療。

醫療人員開立參與藝術、自然與社區活動的「處方」，由跨部會預算支持社區組織，取代單一的藥物治療。

芬蘭

所有政策中的健康
(MHiAP)

跨部會的影響力評估

無論是內政部規劃住宅、或交通部設計大眾運輸，均須嚴格評估政策對弱勢族群心理韌性的影響。

英國世界衛生組織

(WHO)
去機構化與有意義參與

從隔離轉向社區支持。

推動社區為本的照護，並將切身經驗者視為推動服務的平等夥伴（如泰國的同儕支持者計畫）。

行動藍圖一：建立「心理健康影響評估 (MHIA)」機制

·重大社福、住宅、教育、交通與勞動法案送審前，必須回答核心問題：「這項政策對不利處境族群的心理健康有何影響？」

・先期可從社會安全網、長照、身障與新住民政策開始試辦。



行動藍圖二：成立行政院級「心理健康推動委員會」

打破衛福部單打獨鬥的困境。
串聯內政、教育、勞動與交通部，將「年齡別」的預算框架，轉型為精準對焦的「處境別」政策設計。

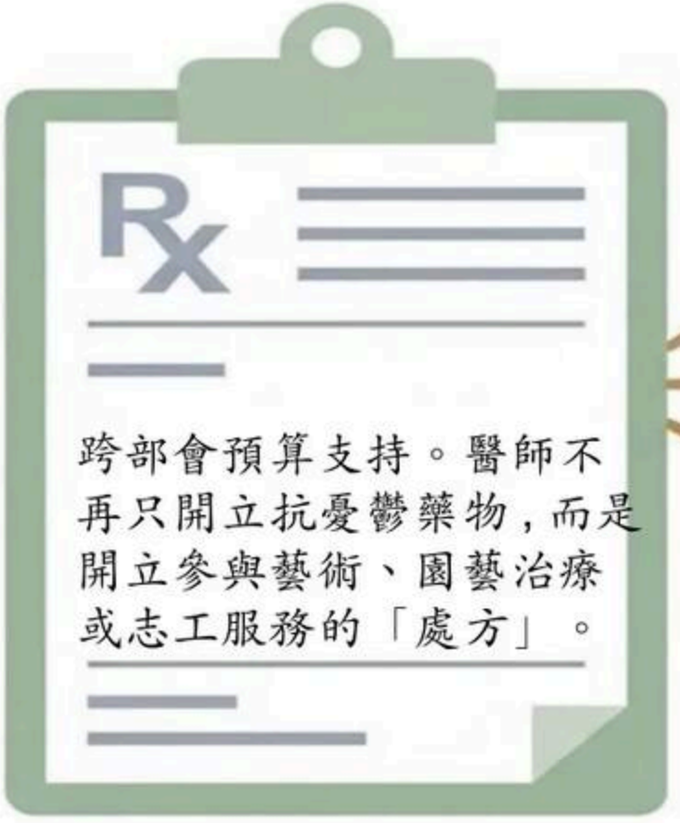




行動藍圖三：社會處方與社區連結

在弱勢族群本就會接觸的入口建立轉介路徑。

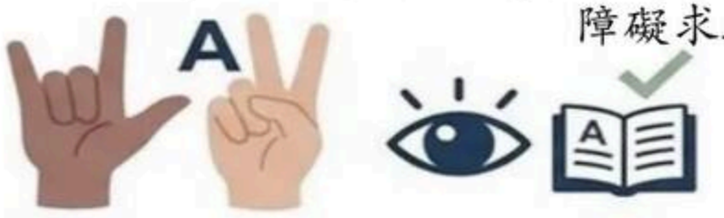
在基層衛生所與關懷據點，建構無障礙環境的單一窗口。將心理健康篩檢，嵌入長照評估、身障鑑定與新住民服務。



重建社區連結，跳出傳統診間醫療。



跨文化翻譯：配置多語通譯，讓新移民婦女無障礙求助及參與



資訊平權：普及易讀版 (Easy-Read) 與手語翻譯。



賦權培力：推動「同儕支持者」培訓，讓長者與身障者成為社區互助核心。



行動藍圖四：落實「真實聲音」倡議倫理

讓切身經驗成為帶動制度變革的動力，而非被二次傷害的工具。

保障法定席次： 政策規劃與評估各階段，保障經驗者的實質參與。讓生活經驗者成為法定夥伴，在中央與地方的政策會議中，保障兒少、長者、身障與新住民代表的法定席次。

媒體敘事翻轉： 建立友善報導指引，拒絕悲情化與污名化標籤，致力呈現求助與復元的真實故事。報導的方式本身，就是心理健康政策最重要的一環。媒體去標籤化：擺脫「悲情化」與「危險化」刻板印象，建立友善報導指引。

「韌性，不是要求弱勢者自己更堅強，
而是社會替他們做好的準備。」

有人聽得懂他們的語言，有人看得見他們的處境，
有人讓他們參與決定自己的人生。
當最不利的人被接住，整個社會才真正安全。

從傾聽走向行動，把心理健康放進每一項政策。